

Disfaji ve Odinofaji

Yutma güçlüğü (disfaji) ve ağrılı yutmanın (odinofaji) yaşa ve mekanizmaya göre ayırıcı tanısı; endoskopi/biyopsi, baryumlu özofagogram ve yüksek çözünürlüklü manometri temelli basamaklı yaklaşım ve dozlu tedavi. EoE, striktür, akalazya ve özofagus halkası odağında.

EoE — ESPGHAN/EUREOS

Rome IV fonksiyonel disfaji

HRM / Chicago sınıflaması

Yaşa göre yaklaşım

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Disfaji, lokmanın ağızdan mideye geçişinde algılanan güçlütür; odinofaji ise yutma sırasında ağrıdır. İlk ayırım orofaringeal (transfer) disfaji ile özofageal disfaji arasındadır: orofaringeal disfaji öksürük, boğulma, nazal regürjitasyon ve aspirasyonla; özofageal disfaji ise göğüste takılma hissi, food impaction ve regürjitasyonla seyreder. Bu ayırım öykü ve muayene ile büyük ölçüde yapılır ve tetkik yolunu belirler.

Orofaringeal = transfer bozukluğu

Özofageal = taşıma bozukluğu

Katı-baskın → mekanik/yapısal

Katı+sıvı → motilite

Odinofaji → inflamatuvar/enfeksiyöz

Öykü

- Başlangıç yaşı ve seyir: doğumdan itibaren (konjenital anomali, nöromusküler) mi, ilerleyici (striktür, akalazya) mi, aralıklı (halka, EoE) mi.
- Lokma niteliği: yalnız katıda mı (mekanik obstrüksiyon), hem katı hem sıvıda mı (motilite bozukluğu) güçlük.
- Yeme davranışı adaptasyonları: yavaş yeme, aşırı çiğneme, bol su ile yutma, belirli kıvamlardan kaçınma, food impaction öyküsü (EoE için tipik).
- Odinofaji varlığı, ilaç alımı (doksisisiklin, NSAİİ, demir, potasyum, bifosfonat — pill özofajiti), kostik/yabancı cisim alımı.
- Atopi zemini: astım, alerjik rinit, egzama, besin alerjisi, ailede EoE (EoE ile güçlü birliktelik).
- İmmün durum, kemoterapi/steroid, HIV; kilo kaybı, büyüme, aspirasyon/pnömoni öyküsü ve nörogelişimsel durum.

Muayene

- Antropometri ve büyüme eğrisi: kilo kaybı/durağanlık kronik obstrüksiyon veya motilite hastalığının erken göstergesi.
- Orofarinks ve dişler: tonsil hipertrofisi, yarık damak, aft/ülser, oral kandidiazis, diş erozyonu.
- Nörolojik muayene: kraniyal sinirler, öğürme refleksi, tonus, bulbar bulgular (orofaringeal disfaji için).
- Yutma gözlemi: salya birikimi, ıslak-boğuk ses, yutma sonrası öksürük, beslenme sırasında desatürasyon.
- Solunum: stridor, hışıltı, tekrarlayan aspirasyon işaretleri (vasküler halka, laringeal yarık).

- Cilt/atopi bulguları; boyunda kitle/guatr; genel durum ve hidrasyon.

Rome IV — Fonksiyonel disfaji: retrosternal takılma/geçiş güçlüğü hissi olup yapısal lezyon, GÖRH ve EoE dışlandığında ve major motilite bozukluğu (akalazya, obstrüktif spazm) bulunmadığında konur; tanı ancak endoskopi + biyopsi ve gerektiğinde manometri normal olduğunda dışlama ile verilir.

02 Etiyoloji ve mekanizma

Disfaji, orofaringeal (transfer) ve özofageal (mekanik veya nöromusküler) olarak ayrılır; odinofaji genellikle mukozal inflamasyon/enfeksiyona işaret eder. Yaş, en olası tanıyı belirlemede güçlü bir filtredir: yenidoğan/süt çocuğunda konjenital ve nöromusküler nedenler, okul çağı ve adölesanda EoE ve akalazya öne çıkar.

Orofaringeal (transfer)

- Nöromusküler: serebral palsi, bulbar/kranial sinir hastalığı, miyopati, prematürite.
- Yapısal: yarı damak, larengomalazi, laringeal yarı, tonsiller hipertrofi.

Mekanik / yapısal (özofageal)

- Peptik striktür, kostik striktür, anastomoz darlığı (ÖA onarımı sonrası), konjenital özofagus stenozu.
- Schatzki halkası, özofagus webi, vasküler halka/pulmoner sling dış bası, yabancı cisim.

Eozinofilik özofajit (EoE)

- Büyük çocuk/adölesanda kronik katı disfaji ve food impaction'ın en sık nedeni; atopi ile güçlü birliktelik.
- Küçük çocukta beslenme reddi, kusma, büyüme geriliği ile atipik; tanı biyopsi ile (≥ 15 eos/BBA).

Motilite bozuklukları

- Akalazya (özofagogastrik bileşke gevşeme yetmezliği + aperistalsis); hem katı hem sıvı disfaji, regürjitasyon, kilo kaybı.
- Özofageal spazm, hiperkontraktıl özofagus, sistemik skleroz ilişkili motilite.

Odinofaji — inflamatuvar/enfeksiyöz

- Erozi/peptik özofajit, ilaç (pill) özofajiti (doksisiklin, NSAİİ, demir, KCl, bifosfonat).
- Enfeksiyöz: Candida, HSV, CMV (özellikle immünsüprese); kostik/kimyasal yanık.

Yaşa göre dağılım

- Yenidoğan/süt çocuğu: konjenital (atrezi/stenoz, halka), nöromusküler, vasküler bası.
- Okul çağı/adölesan: EoE, akalazya, peptik/kostik striktür, pill/enfeksiyöz özofajit.

03 Karar akışı

İlk basamak akut/tehdit edici durumun (tam obstrüksiyon–food impaction, aşırı salivasyon, solunum sıkıntısı, kostik alım) dışlanmasıdır; ardından orofaringeal–özofageal ayrımı yapılır ve özofageal disfajide üst GİS endoskopisi + çok düzeyli biyopsi ilk tanısal adımdır.

BAŞLANGIÇ

Disfaji / odinofaji ile başvuru

Öykü, muayene, yaş filtresi ve orofaringeal–özofageal ayrımı; katı/sıvı paterni ve odinofaji sorgusu.

ADIM 1

Akut tehdit taraması

Tam obstrüksiyon/food impaction, ağızdan salgı yutamama, solunum sıkıntısı, akut kostik/yabancı cisim alımı değerlendirilir.

KARAR 1

Akut/acil bulgu var mı?

Food impaction, aşırı salivasyon, hava yolu tehdidi veya kostik alım mevcut mu?

EVET → Acil müdahale

HAYIR → Elektif değerlendirme

ALARM

Acil endoskopi + hava yolu güvenliği

Food impaction'da acil terapötik endoskopi (impaksiyon sonrası EoE için biyopsi al); kostikte erken endoskopi ve destek; körlemesine bujinaj/kusturma yok.

ADIM 2

Orofaringeal mi, özofageal mi?

Orofaringeal ipuçlarında (aspirasyon, nazal kaçış) VFSS/FEES ± nöroloji; özofageal disfajide özofagus yoluna geç.

KARAR 2

Odinofaji baskın / immünsüpresyon mu?

Ağrılı yutma önde ve ilaç öyküsü ya da immün yetmezlik/enfeksiyon ipucu var mı?

EVET → İnflamatuvar/enfeksiyöz özofajit

HAYIR → Kronik/ilerleyici disfaji

ADIM 3A

Endoskopi + kültür/PCR, hedefli tedavi

ADIM 3B

Üst GİS endoskopisi + çok düzeyli biyopsi

Candida/HSV/CMV için biyopsi-kültür-viral PCR; pill özofajitinde sorumlu ilacı kes ve destek; ampirik antifungal seçilmiş olguda.

Proksimal ve distalden ≥ 6 biyopsi; EoE (≥ 15 eos/BBA), striktür, halka, web ve mukozal hastalık değerlendirilir.

KARAR 3

Biyopsi/endoskopi tanısal mı?

EoE veya belirgin yapısal lezyon (striktür, halka, web) saptandı mı?

EVET → Tanıya yönelik tedavi

HAYIR → Motilite şüphesi

ADIM 4

EoE tedavisi / dilatasyon

EoE'de PPI, topikal steroid veya eliminasyon diyeti; darlıkta kontrollü endoskopik dilatasyon ve altta yatan nedenin tedavisi.

ADIM 5

Baryumlu özofagogram + HRM

Kuş gagası/aperistalsis akalazyayı düşündürür; yüksek çözünürlüklü manometri ile Chicago sınıflaması ve alt tip belirlenir.

KARAR 4

Manometri akalazyaj/major motilite bozukluğu mu?

ÖGB gevşeme yetmezliği + aperistalsis (akalazyaj) doğrulandı mı?

EVET → Akalazyaj yönetimi

HAYIR → Normal tetkik

GİRİŞİM

Pnömatik dilatasyon / Heller / POEM

Alt tipe göre girişimsel tedavi; köprüleme için nifedipin/botulinum toksin. İzlemde beslenme ve büyüme takibi.

SONLANIM

Fonksiyonel disfaji (Rome IV)

Yapısal, EoE ve major motilite dışlanmışsa güvence, yeme davranışı düzenleme ve gerektiğinde nöromodülasyon.

Anahtar ilke: Kronik/ilerleyici özofageal disfajide biyopsili endoskopi ilk tanısal adımdır; food impaction'dan sonra bile EoE'yi dışlamak için biyopsi mutlaka alınır. Baryum ve manometri, endoskopi normal veya motilite şüphesi olduğunda tamamlayıcıdır.

Test seçimi disfajinin tipine göre yönlendirilir: özofageal disfajide biyopsili endoskopi öncelikli; orofaringeal disfajide videofloroskopik yutma çalışması; motilite şüphesinde manometri. Baryumlu özofagogram anatomik lezyonları ve akalazyayı gösterir, dilatasyon planına rehberlik eder.

Disfaji/odinofajide basamaklı tanısal yaklaşım ve endikasyonlar		
BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
Klinik değerlendirme	Tüm olgular	Orofaringeal–özofageal ayrımı, katı/sıvı paterni, odinofaji, yaş filtre ve kırmızı bayrak taraması; tanı yolunu belirler.
Üst GİS endoskopisi + çok düzeyli biyopsi	Proksimal + distal ≥6 parça	Özofageal disfajide ilk adım; EoE tanısı (≥ 15 eos/BBA), erozif/enfeksiyöz özofajit, striktür-halka-web ve normal görünümde bile biyopsi (EoE makroskopik normal olabilir).
Baryumlu özofagogram	Anatomi / motilite ön değerlendirme	Halka (Schatzki), web, striktür uzunluğu, vasküler bası ve akalazyaya (kuş gagası, dilatasyon planına ve cerrahi haritalamaya yardımcı).
Yüksek çözünürlüklü manometri (HRM)	Chicago sınıflaması v4.0	Endoskopi/biyopsi normal + süregelen disfajide; akalazyaya

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
		alt tipleri (I-II-III), ÖGB çıkış obstrüksiyonu, aperistalsis ve spazm ayrımı.
Videofloroskopik yutma çalışması (VFSS) / FEES	Orofaringeal disfaji	Aspirasyon, penetrasyon ve fa güvenliği; kıvam uyarlaması ve beslenme güvenli kararı için (nöromusküler olgularda).
Enfeksiyöz/pill özofajit incelemesi	Odinofaji baskın	Biyopsi + fungal/viral (HSV, CMV) histoloji- kültür-PCR; ilaç v kostik alım öyküsü sorgulanır; immünsüpresyon eşik düşük.
pH-empedans (MII-pH)	Seçilmiş olgular	PPI-yanıtsız EoE ayrımı, reflü ilişkili özofajit/darlık ve motilite-reflü örtüşmesinde; tan yolunu netleştirir.
EndoFLIP / kesitsel görüntüleme	İleri/seçilmiş olgular	EndoFLIP ÖGB distensibilitesini ölçer (akalazya/EoE'de daralma); BT/MR anjiyo vasküler halka ve dış bası şüphesinde.

Food impaction ile başvuran her çocukta impaksiyon giderildikten sonra EoE için biyopsi alınmalıdır; yalnızca cisme müdahale edip biyopsi almamak en sık gözden kaçan hatadır.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular acil veya hızlandırılmış girişimsel/tanısal değerlendirme gerektirir; fonksiyonel/benign disfaji varsayımını geçersiz kılar.

- Tam obstrüksiyon / food impaction: salgıyı yutamama, aşırı salivasyon.

- Solunum sıkıntısı, stridor, beslenmede desatürasyon veya akut aspirasyon.

- Kostik/kimyasal madde alımı öyküsü (oral yanık olmasa bile).

- İlerleyici disfaji + belirgin kilo kaybı / büyüme geriliği.

- Hem katı hem sıvıya disfaji + regürjitasyon (akalazya).

- Hematemez, melena veya belirgin odinofaji + ateş.

- Yenidoğan/erken süt çocuğunda beslenmeyle öksürük-mor olma (vasküler halka, laringeal yarık, atrezi).

- Tekrarlayan aspirasyon pnömonisi.

- İmmünsüpresyon zemininde yeni başlayan odinofaji.

- Boyunda kitle, ses değişikliği veya ilerleyici nörolojik bulgu.

Food impaction ve kostik alım acil durumlardır: körlemesine bujinaj, kusturma veya beklemeci tutum yerine hava yolu güvenliği sağlanarak zamanında endoskopi planlanır.

06 Tedavi — dozlu

Tedavi altta yatan nedene göre şekillenir. EoE'de üç birinci basamak seçenek vardır: PPI, yutulan topikal kortikosteroid ve eliminasyon diyeti; darlıkta endoskopik dilatasyon eklenir. Akalazyada girişimsel tedavi (pnömatik dilatasyon, Heller miyotomi, POEM) esastır. Odinofajide enfeksiyöz/ilaç etkeni hedeflenir. Dozlar hastaya göre bireyselleştirilmelidir.

EoE: PPI / topikal steroid / diyet

Striktür: dilatasyon + neden tedavisi

Akalazyaya: PD / Heller / POEM

Odinofaji: etkene yönelik

Nedene yönelik tedavi — doz (mg/kg) ve maksimumlar

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Omeprazol (EoE, yüksek doz PPI)	1-2 mg/kg/gün, 2 doza bölünmüş (maks 40 m
Esomeprazol (EoE, alternatif PPI)	1 mg/kg/doz, günde 2 (maks 40 mg/gün)
Oral viskoz budesonid (yutulan)	<10 yaş 1 mg/gün; ≥10 yaş/adölesan 2 mg/gü
Yutulan flutikazon (ölçülü doz, boşluğa sıkıp yutma)	<10 yaş 88-440 mcg/gün; ≥10 yaş 440-880 mc
Budesonid orodispersibl tablet	Adölesan: 1 mg, günde 2 (maks 2 mg/gün)

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Eliminasyon diyeti (empirik)	1/2/4/6-besin veya aminoasit formül
Endoskopik özofagus dilatasyonu	Girişim — kademeli/kontrollü
Flukonazol (Candida özofajiti)	6 mg/kg (1. gün yükleme), sonra 3 mg/kg/gün
Asiklovir (HSV özofajiti)	IV 5-10 mg/kg/doz, 8 saatte bir (7-14 gün)
Gansiklovir (CMV özofajiti)	IV 5 mg/kg/doz, günde 2 (indüksiyon)
Pill özofajiti yönetimi	Sorumlu ilacı kes + destek

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Akalazya — köprüleme (nifedipin)	0.3-0.5 mg/kg/gün, yemek öncesi (maks 30 m
Akalazya — girişimsel tedavi	Pnömatik dilatasyon / Heller miyotomi / POE

EoE'de birinci basamak PPI, topikal steroid ve eliminasyon diyeti benzer etkinliktedir; seçim hastanın tercihine, uyuma ve fenotipe göre yapılır. İndüksiyon sonrası histolojik yanıt endoskopi + biyopsi ile doğrulanır ve yanıt varsa idame sürdürülür (EoE kronik-relapsing seyreder).

Amaç: acil komplikasyonları (impaksiyon, aspirasyon) önlemek, EoE'de histolojik remisyonu ve fibrostenozu, akalazyada semptom kontrolü ve beslenmeyi izlemektir. İzlem klinik semptomla sınırlı kalmaz; özellikle EoE'de histoloji rehberdir.

EoE ve mukozal hastalık izlemi

- İndüksiyon sonrası 8-12 haftada kontrol endoskopi + biyopsi ile histolojik remisyon (<15 eos/BBA) doğrula.
- Yanıtta idame tedavisi sürdür; semptomlar histolojiyle her zaman uyuşmaz ("asemptomatik aktif hastalık").
- Eliminasyon diyetinde besinleri kademeli reintrodüksiyon + her adımda biyopsi ile tetikleyiciyi belirle.
- Fibrostenoz/darlık gelişimini izle; dilatasyonu medikal tedaviyle birlikte planla, atopiyi ortak yönet.

Yapısal / motilite hastalığı izlemi

- Striktürde neden tedavisi (PPI, EoE tedavisi) + dilatasyon; rekürren darlıkta tekrar değerlendirme.
- Akalazyada girişim sonrası semptom, kilo/büyüme ve reflü/özofajit gelişimini izle; Eckardt benzeri semptom skoru takibi.
- Orofaringeal disfajide VFSS ile kıvam/pozisyon uyarlaması, aspirasyon önlemi ve beslenme ekibi ile ortak izlem.
- Vasküler halka/konjenital lezyonda cerrahi sonrası büyüme ve rezidü semptom takibi.

Geri çekilme ve devam kuralı: EoE ve akalazyaya kronik hastalıklardır; semptom düzelse bile objektif remisyon (histoloji/manometri-klinik) doğrulanmadan tedavi kesilmez. Fonksiyonel disfaji tanısı ancak yapısal, EoE ve major motilite bozukluğu dışlandığında konur.

Kaynaklar

1. Amil-Dias J, Oliva S, Papadopoulou A, ve ark. Diagnosis and management of eosinophilic esophagitis in children: An update from the ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024;79(2):394-437.

2. Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias Á, ve ark. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults (UEG/EAACI/ESPGHAN/EUREOS). United European Gastroenterol J. 2017;5(3):335-358.
3. Dellon ES, Liacouras CA, Molina-Infante J, ve ark. Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: Proceedings of the AGREE Conference. Gastroenterology. 2018;155(4):1022-1033.
4. Aziz Q, Fass R, Gyawali CP, ve ark. Functional Esophageal Disorders (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1368-1379.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü değerlendirmenin, güncel kılavuzların ve yerel ilaç ruhsat/dozaj bilgilerinin yerine geçmez. Dozlar hastanın yaşı, kilosu, böbrek/karaciğer fonksiyonu ve komorbiditelerine göre bireyselleştirilmelidir.